

जनस्वास्थ्य_सेवा_ऐन_२०७५

English title: Public Health Service Act, 2018

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ । प्रमाणीकरण मिति २०७५ । ६ । २ । संवत् २०७५ सालको ऐन नम्बर ११ । जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको नशिलक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाउने हक कार्यान्वयन गर्न र स्वास्थ्य सेवालाई नियमिति, प्रभावकारी, गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ तुल्याई नागरिकको पहुँच स्थापति गर्नका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षेपित नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा" भन्नाले आकस्मिक घटना वा आपतकालीन अवस्था परी जीवन जोखिमियुक्त अवस्थामा रहेका व्यक्तहरूको जीवनलाई जोखिमियुक्त गर्न, जीवन वा अङ्ग गुम्नबाट बचाउन आवश्यकता अनुसार दनुपर्ने प्रारम्भिक तथा तत्काल सेवा सम्झनु पर्छ । (ख) "आधारभूत स्वास्थ्य सेवा" भन्नाले दफा ३ को उपदफा (४) बमोजमि आम नागरिकको स्वास्थ्य आवश्यकता पूरतकि लागि राज्याबाट सुलभ रूपमा नशिलक उपलब्ध हुने प्रबर्द्धनात्मक, प्रतकिरात्मक, नदिनात्मक, उपचारात्मक र पुनस्थापनात्मक सेवा सम्झनु पर्छ । (ग) "गैरसरकारी वा नजि स्वास्थ्य संस्था" भन्नाले प्रचलति कानून बमोजमि स्वीकृति लाई गैरसरकारी वा नजि क्षेत्रको लगानी तथा स्वामित्वमा सञ्चालन भएका स्वास्थ्य संस्था सम्झनु पर्छ । (घ) "चकित्सक" भन्नाले प्रचलति कानून बमोजमि चकित्सकको रूपमा सम्बन्धति परिषद्मा दर्ता भएको व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (ङ) "जनस्वास्थ्य नरीक्षक" भन्नाले जनस्वास्थ्य सम्बन्धी अनुगमन नियमनको लागि तोकिएको पदाधिकारी सम्झनु पर्छ । (च) "जोखमियुक्त क्षेत्र" भन्नाले कार्यस्थल वा कार्य प्रकृतिका कारण मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने कुनै पनिरासायनकि, जैवकि, जलवायु परिवर्तन जन्य, मनोसामाजकि, शारीरिक, भौतिक तथा भौगोलकि अवस्था रहेको कार्यक्षेत्रलाई सम्झनु पर्छ र सो शब्दले स्वास्थ्य उपचारका बेला स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई हुने सम्भाव्य जोखमि समेतलाई जनाउनेछ । (छ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजमि" भन्नाले यस ऐन बमोजमि बनेका नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि सम्झनु पर्छ । (ज) "परम्परागत उपचार प्रदायक" भन्नाले परम्परागत रूपमा जडबुटी, जान्तव र खनजिबाट उपचार प्रदान गर्ने व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (झ) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सम्बन्धी वषिय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ञ) "समिति" भन्नाले दफा ५० बमोजमिको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समितिसम्झनु पर्छ । (ट) "सरकारी स्वास्थ्य संस्था" भन्नाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालति स्वास्थ्य संस्था सम्झनु पर्छ । (ठ) "सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता" भन्नाले मान्यता प्राप्त संस्थाबाट स्वास्थ्य सेवाका वषियमा तोकिएका योग्यता वा तालीम हासलि गरी संस्था वा समुदायमा कार्य गर्ने स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवकि समेतलाई सम्झनु पर्छ । (ड) "सेवाग्राही" भन्नाले स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य सेवा लनि व्यक्तिसम्झनु पर्छ ।

(ढ) "सेवा प्रदायक" भन्नाले मान्यता प्राप्त शकिषण संस्थाबाट स्वास्थ्य सेवाका वषियमा नशिचति योग्यता वा तालीम हासलि गरी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता सम्झनु पर्छ । (ण) "स्वास्थ्यकर्मी" भन्नाले प्रचलति कानून बमोजमि स्वास्थ्यकर्मीको रूपमा सम्बन्धति परिषद्मा दर्ता भएको व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (त) "स्वास्थ्य सेवा" भन्नाले आधुनकि चकित्सा (एलोप्याथी), आयुर्वेद, होमीयोप्याथी, युनानी, प्राकृतकि चकित्सा, अकुपञ्चर, सोवारगिपा (आम्ची) चकित्सा पद्धतमि आधारति भई प्रदान गरनि प्रतकिरात्मक, प्रबर्द्धनात्मक, नदिनात्मक, उपचारात्मक, पुनस्थापनात्मक र प्रशामक (पालिएटिभि) सेवा सम्झनु पर्छ । (थ) "स्वास्थ्य संस्था" भन्नाले सरकारी स्वास्थ्य संस्था सम्झनुपर्छ र सो शब्दले प्रचलति कानून बमोजमि स्थापति गैरसरकारी वा नजि वा सहकारी वा गैर नाफामूलक सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थालाई समेत जनाउँछ । परिच्छेद-२ । सेवाग्राहीको अधिकार, कर्तव्य तथा स्वास्थ्य संस्थाको दायित्व । ३. स्वास्थ्य सेवाको पहुँच तथा सुनशिचितता: (१) प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज र सर्वसुलभ रूपमा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको सेवा प्राप्त गर्ने प्रयोजनको लागि प्रचलति कानून तथा नेपाल सरकारले समय समयमा तोके बमोजमिको स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रममा समावेश हुनु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुनेछ । (३) कुनै पनिरागिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चति गरनि छैन । (४) प्रत्येक नागरिकलाई देहायका शीर्षक अन्तर्गतका तोकिए बमोजमिका आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू नशिलक प्राप्त गर्ने हक हुनेछ :- । (क) खोप सेवा, । (ख) एकीकृत नवजात शशि तथा बालरोग व्यवस्थापन, पोषण सेवा, गर्भवती, प्रसव तथा सुत्केरी सेवा, परिवार नियोजन, गर्भपतन तथा प्रजनन स्वास्थ्य जस्ता मातृ, नवजात शशि तथा बाल स्वास्थ्य सेवा, । (ग) सरुवा रोग सम्बन्धी सेवा, । (घ) नसर्ने रोग तथा शारीरिक बकिलाङ्गता सम्बन्धी सेवा, । (ङ) मानसकि रोग सम्बन्धी सेवा, । (च) ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा, । (छ) सामान्य आकस्मिक अवस्थाका सेवा, । (ज) स्वास्थ्य प्रबर्द्धन सेवा, । (झ) आयुर्वेद तथा अन्य मान्यता प्राप्त वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवा, ।

(ज) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना जारी गरी तोकेका अन्य सेवा । (५) उपदफा (४) बमोजमि नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरूमा आवश्यकता अनुरूप प्रदेश वा स्थानीय सरकारले थप गर्न सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि थप गरिएका सेवाहरूको आर्थिक व्ययभार सम्बन्धित सरकारले व्यहोर्नु पर्नेछ । (७) उपदफा (४) बमोजमिका सेवाहरूको वसितुत वविरण, सेवा प्रवाह तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तथा प्रक्रिया मन्त्रालयले तोके बमोजमि हुनेछ । (८) स्थानीय तहले प्रदेश तथा सङ्घ अन्तर्गत सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरूको साझेदारीमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्नेछ । ४. आकस्मिक उपचार: (१) प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाहरूले तोकिए बमोजमिका आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु प्रत्येक स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीको कर्तव्य हुनेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुन नसकेमा त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाले सो संस्थाबाट उपलब्ध हुने उपचार तत्काल उपलब्ध गराई थप उपचारका लागि अन्य स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषण गर्नु पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजमि उपचार गर्दा लागेको खर्च सम्बन्धित व्यक्तिको स्वास्थ्य बीमा भएकोमा सोबाट र स्वास्थ्य बीमा नभएकोमा वा स्वास्थ्य बीमाको रकमले नपुग्ने भएमा सम्बन्धित व्यक्ति, नजिको अभिभावक, परिवारको सदस्य, संरक्षक वा संरक्षकत्व ग्रहण गरिएको व्यक्तिले व्यहोर्नु पर्नेछ । तर, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत पर्ने स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य संस्थाले निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजमि आकस्मिक उपचार सेवा प्रदान गर्दा सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई उपचार सुरु गरिसकेपछि मात्र त्यस्तो सेवा प्राप्त गर्दा पूरा गर्नु पर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्न लगाउनु पर्नेछ । (६) आकस्मिक उपचार सेवा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ५. विशेषज्ञ सेवा: (१) नेपाल सरकारले सेवाको प्रकृति, भौगोलिक अवस्था तथा रोगको प्रकोप दरका आधारमा आवश्यकता अनुसार तोकिएका वशिष्टीकृत सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) सङ्घीय कानूनले तोकेको मापदण्ड बमोजमि प्रदेश सरकारले विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ६. प्रेषण (रेफरल) सेवा: (१) प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले उपचारको लागि आएको बरिमीलाई आफ्नो स्वास्थ्य संस्थाको संरचना, उपकरण, विशेषज्ञ सेवा नभएको वा अन्य कुनै उपयुक्त कारणले उपचार प्रदान गर्न नसकिने अवस्था भएमा आफ्नो संस्थामा उपलब्ध हुने सेवा प्रदान गरी थप उपचारका लागि तुरन्त त्यस्तो बरिमीलाई उपचार प्रदान गर्न सक्ने स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषण गर्नु पर्नेछ । (२) स्वास्थ्य संस्थाले उपदफा (१) बमोजमि प्रेषण गर्दा तोकिए बमोजमिका वधि र प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेछ । (३) विशेषज्ञ सेवा र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहबीच आवश्यक प्रेषण प्रणाली स्थापना गरी सेवा प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आपतकालीन उपचारको क्रममा रहेका बरिमीलाई प्रेषण गर्दा प्रेषित गर्ने स्वास्थ्य संस्थाले आफूसँग रहेका न्यूनतम स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरण एवं उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधा सहित प्रेषित गर्नु पर्नेछ । ७. गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने: (१) नेपाल सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य संस्थाबाट गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनेछ । (२) नेपाल सरकारले उपलब्ध श्रोत साधनको आधारमा नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न देहायका कार्यहरू गर्नेछ:- ।

(क) नागरिकको स्वास्थ्यको संरक्षण र संवर्द्धन लागू नीति निर्धारण गर्ने, । (ख) स्वास्थ्य सेवाको प्राथमिकता निर्धारण गरी समतामूलक तवरबाट सेवा उपलब्ध गराउने । (३) यो ऐन कार्यान्वयन गर्न सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आवश्यकताको आधारमा तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना गरी त्यस्ता संस्थामा आवश्यक जनशक्ति, प्रवर्धि तथा उपकरणको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । ८. सेवाग्राहीको कर्तव्य : स्वास्थ्य संस्थामा वा स्वास्थ्यकर्मीसँग सेवा लनि सेवाग्राहीको कर्तव्य देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) आफ्नो स्वास्थ्यको सम्बन्धमा सचेत रहने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाउने, योग तथा शारीरिक व्यायाम गर्ने तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवा उपभोग गर्ने, । (ख) स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्तिले स्वास्थ्य संस्थाको नियमको पालना गर्ने, । (ग) स्वास्थ्य संस्थालाई आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थसँग सम्बन्धित यथार्थ जानकारी उपलब्ध गराउने र स्वास्थ्य सेवा लैँदा स्वास्थ्यकर्मीलाई सहयोग गर्ने, । (घ) स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको मर्यादा र सम्मान गर्ने, । (ङ) स्वास्थ्यकर्मीप्रति शारीरिक, मानसिक वा लैङ्गिक हिंसा हुने काम नगर्ने, । (च) सफाई गरिएको आंशिक वा पूरा उपचार लनि अस्वीकार गरेको अवस्थामा उपचार काण्ड वा डिसिचार्ज सर्टिफिकेटमा उल्लेख गरी हस्ताक्षर गर्ने, । (छ) दफा ६ को अधीनमा रही स्वास्थ्य संस्थाले प्रेषण गरेको स्वास्थ्य संस्थामा गई सेवा लनि । ९. उपचार गराउने दायित्व हुने : परिवारका सदस्य, संरक्षक वा संरक्षकत्व स्वीकार गरिएको कुनै पनित्यक्त बरिमी भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई स्वास्थ्य संस्थामा लैजानु, उपचार गराउनु, उपचार खर्च व्यहोर्नु र उपचार गर्ने कार्यमा सहयोग तथा सहजीकरण गर्नु अभिभावक, परिवारका सदस्य, संरक्षक तथा संरक्षकत्व स्वीकार गरिएको व्यक्तिको दायित्व हुनेछ । १०. सेवाग्राहीलाई जानकारी दिनु पर्ने : (१) प्रत्येक स्वास्थ्य संस्था तथा उपचार प्रदान गर्ने स्वास्थ्यकर्मीले सेवाग्राहीलाई देहायका वषियमा जानकारी दिनु पर्नेछ :- । (क) प्रत्येक सेवाग्राहीलाई आफ्नो स्वास्थ्य र उपचारको अवस्था सम्बन्धमा, । तर सेवाग्राहीको स्वास्थ्य स्थितिको सूचना दैँदा नजिको वा समुदायको हति विपरीत हुन सक्ने पर्याप्त आधार भएमा स्वास्थ्य संस्थालाई त्यस्तो सूचना गोप्य राख्न कुनै

बाधा पर्ने छैन । (ख) रोगको नदिन, नदिन भएको रोगको प्राकृतिक परिणाम र उपचारसँग सम्बन्धित सेवाको सूत्र र वकिलप सम्बन्धमा, । (ग) स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी वकिलपसँग सम्बन्धित अनुमानति खर्च र सम्भावित परिणाम सम्बन्धमा, । (घ) सेवाग्राहीले स्वास्थ्य सेवा अस्वीकार गर्न सक्ने र सेवा अस्वीकार गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित परिणाम, जोखिम र दायित्व सम्बन्धमा । (२) स्वास्थ्य संस्थाले सेवाग्राहीलाई उपदफा (१) बमोजिमको जानकारी उपलब्ध गराउँदा सम्भव भएसम्म नजिले बुझ्न सक्ने भाषामा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सेवाग्राहीको स्वास्थ्य स्थितिको सूचना सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई दनि नसकिने अवस्थामा नजिको परिवारको उमेर पुगेको सदस्यलाई दनि पर्नेछ । ११. सेवाग्राहीको सुसूचित सहमति (इन्फर्मड कन्सेन्ट) लनिपर्ने : (१) प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले सेवाग्राहीलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदा नजिको सुसूचित सहमतिलिनि पर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "सुसूचित सहमति" भन्नाले कानूनी रूपले सक्षम व्यक्तिले स्वास्थ्य सेवा लनि दिएको लेखित वा मौखिक सहमति समझनु पर्छ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि तोकिएको उपचार प्रदान गर्न लेखित सहमतिलिनि पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा सेवाग्राहीको सुसूचित सहमति बिना स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सकिनेछ:- । (क) सेवाग्राहीले सहमति प्रदान गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको र कसैलाई पनि त्यस्तो सहमति प्रदान गर्ने अनुमति वा अख्तियारी नदिएकोमा उपलब्ध भएसम्म क्रमशः नजिको पति वा पत्नी, बाबु वा आमा, हजुरबुवा वा हजुरआमा, उमेर पुगेको छोरा वा छोरी, दाजुभाइ वा दादीबहनी वा उपलब्ध सेवाग्राहीको नकिटतम व्यक्तिले सहमति दिएको अवस्थामा, । (ख) प्रचलित कानून वा अदालतको आदेश बमोजिम सहमति बिना नै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराएको अवस्थामा, । (ग) कुनै व्यक्तिलाई उपचार गर्दा जनस्वास्थ्यमा गम्भीर खतरा उत्पन्न हुने अवस्था रहेकोमा, । (घ) स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन ढिलाई गरिएमा सम्बन्धित बरिामीको मृत्यु हुन सक्ने वा नजिको स्वास्थ्यमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने सम्भावना रहेकोमा, । (ङ) सम्बन्धित व्यक्तिले व्यक्त वा अव्यक्त रूपमा वा आचरणद्वारा स्वास्थ्य सेवा लनि अस्वीकार नगरेकोमा, । (च) तोकिए बमोजिमको अन्य अवस्था । १२. समान व्यवहार गर्नु पर्ने : (१) यस ऐन बमोजिम उपचार गर्दा सबै सेवाग्राहीप्रति समान तथा आदरपूर्ण व्यवहार गर्नु सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मीको कर्तव्य हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बरिामीको स्वास्थ्यको गम्भीरताको आधारमा स्वास्थ्य संस्थाले उपचार गर्दा प्राथमिकताकरण गर्न सक्नेछ । (३) कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाले कसैलाई नजिको उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात जाति, लडिग, पेशा, यौनिक तथा लैङ्गिक पहिचान, शारीरिक वा स्वास्थ्य अवस्था, अपाङ्गता, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा उपचारमा भेदभाव गर्नु, गराउनु हुँदैन । १३. पेशागत आचरण : स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीले सम्बन्धित परिषदहरूले निर्धारण गरे बमोजिमका पेशागत आचरण पालना गर्नु पर्नेछ । १४. गोपनीयता कायम राख्ने : (१) स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीको स्वास्थ्य अवस्था, नदिन वा नजिले प्राप्त गरेको उपचार लगायतका सूचनाहरू गोप्य राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा सूचना सार्वजनिक गर्न यस दफाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन:- ।

(क) सूचना सार्वजनिक गर्न सेवाग्राहीले लेखित सहमति दिएमा, । (ख) अदालतको आदेश वा प्रचलित कानून बमोजिम सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएमा, । (ग) सूचना सार्वजनिक नगर्दा त्यसबाट जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने देखिएमा । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) को प्रयोजनको लागि जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा तोकिएको अधिकारीले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ । १५. डिसिचार्ज (बह्रिगमन) सारांश दनि पर्ने : प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा भर्ना भई उपचार गराइरहेको बरिामीलाई डिसिचार्ज गर्दा त्यस्ता संस्थाले तोकिए बमोजिमको जानकारी सहितको डिसिचार्ज सारांश दनि पर्नेछ । १६. स्वास्थ्य संस्थाको दायित्व : (१) प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले योग्य सेवा प्रदायकबाट मात्र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ । (२) प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले कुनै पनि रोगको सङ्क्रमण नहुने र रोक्ने तरफ आवश्यक सुरक्षात्मक उपायको अवलम्बन गर्नु पर्नेछ । (३) प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले आफूले उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित देहायको सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ:- । (क) उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा, सोको प्रकृति, लाग्ने अनुमानति समय र लागत, । (ख) कार्य सञ्चालन तालिका र चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीको समय तालिका, । (ग) स्वास्थ्य सेवामा पहुँच स्थापित गर्ने कार्यवधि, । (घ) गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यवधि । १७. स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी गराउने : (१) कसैले दुर्घटना वा अन्य कुनै कारणले कुनै व्यक्तिलाई उपचारको लागि कुनै स्वास्थ्य संस्थामा लग्नेमा त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाले त्यस्तो व्यक्तिलाई तत्काल आफूसँग उपलब्ध भएसम्मको उपचारको सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो व्यक्तिको पहिचान हुन नसकेमा सोको जानकारी तत्काल सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनलाई दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम स्वास्थ्य संस्थाले सूचना दैँदा उपचार गरिएको व्यक्ती नजिसँग सम्बन्धित उपलब्ध भएसम्मको अन्य जानकारी समेत दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम जानकारी प्राप्त भएपछि स्थानीय प्रशासनले सम्बन्धित व्यक्तिको परिवार, अभिभावक वा संरक्षकको खोजी गरी सोको जानकारी गराउनु पर्नेछ । १८. उजुरी गर्न सक्ने : उपचारको क्रममा कुनै सेवाग्राहीको स्वास्थ्यमा थप जटिलता देखा परेमा वा उपचारको प्रक्रियाप्रति नजिलाई कुनै आशङ्का भएमा नजिले उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था प्रतितोकिएको निकायमा तोकिए बमोजिम उजुरी गर्न सक्नेछ । १९. शर्त

बन्देज लगाउन सक्ने : स्वास्थ्य संस्थाको प्रमुखले प्रचलित कानून बमोजमि स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको स्वास्थ्य स्थितिको आधारमा स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गर्ने सेवामा नशिचति शर्त बन्देज लगाउन सक्नेछ । २०. आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्ने : प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही कर्मचारीको सुरक्षा र रोगको संक्रमण नहुने र रोक्ने तरफ आवश्यक उपायको अवलम्बन गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद - ३ ।

स्वास्थ्य प्रणाली र सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धी । २१. स्वास्थ्य संस्थाको सञ्चालन र नियमन : (१) स्वास्थ्य संस्थाहरूको तहगत संरचना र सो संस्थाले प्रदान गर्ने सेवा सम्बन्धी व्यवस्था मन्त्रालयले तोके बमोजमि हुनेछ । (२) स्वास्थ्य संस्था तथा सेवा सम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड मन्त्रालयबाट निर्धारण भए बमोजमि हुनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको मापदण्ड अधीनमा रही प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाहरूले सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ । (४) यस ऐन प्रारम्भ हुनुपूर्व स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको स्वास्थ्य संस्थाहरूले मन्त्रालयले तोकेको समय भित्र उपदफा (२) बमोजमि तोकिएको मापदण्ड पुरा गर्नु पर्नेछ । (५) स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले नजिी वा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थासँग आवश्यक साझेदारी गर्न सक्नेछन् । (६) नजिी तथा गैरसरकारी, नजिी वा सहकारी वा गैर नाफामूलक वा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गर्ने सेवाको मापदण्ड, इजाजत तथा नियमनको व्यवस्था नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी निर्धारण गर्न सक्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि निर्धारण भएको मापदण्ड बमोजमि सङ्घ, सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र दनि सक्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजमि प्रदेश र स्थानीय तहबाट स्वास्थ्य संस्थालाई इजाजतपत्र दनि, नवीकरण गर्ने तथा त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा नियमन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय कानून बमोजमि हुनेछ । (९) उपदफा (८) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश वा स्थानीय कानून नबनेसम्मको लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहले यस ऐन बमोजमि स्वास्थ्य संस्थालाई इजाजतपत्र दनि, नवीकरण गर्न, अनुगमन गर्न वा नियमन गर्न सक्नेछन् । २२. इजाजतपत्र प्राप्त गर्नु पर्ने: (१) गैरसरकारी वा नजिी स्वास्थ्य संस्थाले तोकिए बमोजमि इजाजतपत्र लिएर मात्र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ । (२) यस ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत इजाजत नलाई सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूले मन्त्रालयले तोकेको समयभित्र उपदफा (१) बमोजमिको इजाजतपत्र लनु पर्नेछ । (३) परम्परागत उपचार सेवाको हकमा स्थानीय तहले तोकेको मापदण्ड बमोजमि स्वीकृतिलाई सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ । २३. स्वतः खारेज हुने: दफा २१ बमोजमि तोकिएका मापदण्ड पुरा नगर्ने र दफा २२ बमोजमि इजाजतपत्र नलाई सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको इजाजतपत्र स्वतः खारेज भएको मानिनेछ । २४. स्वास्थ्य संस्था बाहेक अन्यत्रबाट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने: (१) स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले शैक्षिक संस्थासँग सहकार्य गरी विद्यालय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्रदान गरिने विद्यालय स्वास्थ्य सेवाको प्रकृति मापदण्डहरू सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले तोके बमोजमि हुनेछ । (३) कुनै स्वास्थ्य संस्थाले सम्बन्धित प्रदेशको तोकिएको नकियाबाट अनुमतिलाई घुम्ती शविरिहरू मार्फत वशिषज्ज सेवाहरू सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजमि घुम्ती स्वास्थ्य शविरि प्रदान गर्दा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया र मापदण्ड प्रदेश सरकारले तोके बमोजमि हुनेछ । (५) घर घरमा दडिने स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया र मापदण्ड स्थानीय तहले तोकेबमोजमि हुनेछ । २५. स्वास्थ्य संस्थाले गुणस्तर कायम गर्नु पर्ने: (१) स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने कार्य सङ्घीय कानून बमोजमि हुनेछ । (२) मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवाहरूको मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्न वा गराउन सक्नेछ । (३) यस दफा बमोजमिको मापदण्ड पूरा नभएको सम्बन्धमा तोकिएको नकियाले समय समयमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि भएको अनुगमन र मूल्याङ्कनपछि सम्बन्धित नकियाले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । २६. मानव स्रोतको व्यवस्थापन र विकास: (१) नेपाल सरकारले स्वास्थ्यक्षेत्रको मानव स्रोतको विकास, वितरण र उपयोग सम्बन्धी नीति एवं मापदण्ड तयार गरी लागू गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको मापदण्ड तोकदा मानवस्रोतको विकास, व्यवस्थापन, उपयोगको वषियमा दीर्घकालीन, मध्यकालीन र तत्कालीन आवश्यकताको वशिलेखन र नक्सामा गरी जनशक्ति, प्रवर्धित तथा उपकरणको प्रक्षेपणको आधारमा तोकनु पर्नेछ । २७. अनुसन्धान, नियमन, गुणस्तर मापन तथा अनुगमन: (१) स्वास्थ्य संस्था तथा सेवा प्रदायकले तोकिएको मापदण्ड अनुरूप गुणस्तर कायम गरे नगरेको सम्बन्धमा नेपाल सरकार र तोकिएको नकियाले नियमन, निरीक्षण, अनुगमन, अनुसन्धान र मूल्याङ्कन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गरिएको निरीक्षण, अनुसन्धान तथा अनुगमनबाट प्राप्त नतजिका संस्थाले उल्लिखित मापदण्डहरूको पालना नगरेका कारण जनस्वास्थ्यमा प्रभाव पर्ने देखिएमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना र सञ्चालनको स्वीकृति दिने नकियाले त्यस्ता संस्था बन्द गर्ने आदेशसम्म दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको आदेश बमोजमि संस्था बन्द गर्ने गराउने जमिमेवारी सम्बद्ध सरकारको हुनेछ । (४) अनुसन्धान, नियमन, गुणस्तर मापन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गरिनेछ । २८. स्वास्थ्य वृत्ति र सामाजिक सुरक्षा: (१) जनस्वास्थ्यलाई प्रभाव पार्ने वस्तु उत्पादन तथा क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि लगाइने करबाट सङ्कलन भएको रकमबाट छुट्टै स्वास्थ्य कोष खडा गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा देहाय बमोजमिको रकम रहनेछन् :- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ग) स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम, । (घ) गैरसरकारी तथा नजिी सङ्घ संस्थाबाट

प्राप्त रकम, (ड) वदिशी सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त रकम । (३) उपदफा (१) बमोजमि खडा भएको कोषको रकम जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि खडा भएको कोषको सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । (५) नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी व्यवस्था प्रचलति कानून बमोजमि हुनेछ ।

२९. औषधिको मूल्य, प्रेस्क्रिप्सन, फार्मेसी र नशिलुक औषधिसम्बन्धी व्यवस्था: (१) चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले औषधि सफारसि गर्नु पर्दा जेनेरिक नाम लेख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गुणस्तरीय स्वदेशी उत्पादनको हकमा यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्ष भित्र उपदफा (१) बमोजमि हुनेगरी कार्य गर्नुपर्नेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पेटेन्ट र नयाँ औषधिको हकमा ब्राण्ड नाममा सफारसि गर्न बाधा पर्ने छैन । (४) प्रत्येक सरकारी अस्पतालहरूले आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गरी सुपथ मूल्यमा औषधिहरूको नियमिति उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ । (५) औषधिको मूल्य निर्धारण नेपाल सरकारले तोके बमोजमि हुनेछ । (६) प्रत्येक स्वास्थ्य संस्था तथा सेवा प्रदायकले औषधिको समुचित प्रयोग तथा प्रवर्धन गर्ने गरी स्तरीय उपचार पद्धतिको पालना गर्नु पर्नेछ । (७) औषधि बिक्रीताले औषधिको तोकिए बमोजमिको गुणस्तर कायम रहने गरी भण्डारण तथा बिक्री वितरण गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (८) औषधि बिक्रीताले चिकित्सकको सफारसि बनि कुनै पनि औषधि बिक्री वितरण गर्न पाउने छैन । (९) औषधिसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचलति कानून बमोजमि हुनेछ । ३०. वैदेशिक उपचार वापत खर्च उपलब्ध नहुने: प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई वदिशमा उपचार गर्नु पर्ने भएमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन । ३१. वसितारति अस्पताल सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने: (१) स्वास्थ्य संस्थाले उपलब्ध स्रोत साधन र जनशक्तिको आधारमा आवश्यकता अनुसार वसितारति अस्पताल सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको सेवा उपलब्ध गराउने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थाले सो सेवा उपलब्ध गराए वापत अतिरिक्त भत्ता र अन्य सुविधा प्रदान गर्नु पर्नेछ । ३२. अन्यत्र सेवा गर्न नपाउने: (१) सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी वा कर्मचारीले सम्बन्धित निकायले तोकेको समयमा अन्यत्र सेवा गर्न पाउने छैन । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित समय बाहेकको समयमा कुनै चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी वा कर्मचारीले अन्यत्र सेवा गर्न चाहेमा सम्बन्धित निकायको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ । ३३. आकस्मिक स्वास्थ्य उपचार कोष स्थापना गर्न सक्ने: (१) मन्त्रालय र प्रदेश सरकारले गरीब तथा वपिन्न तथा घर ठेगाना पत्ता नलागेको व्यक्ति, जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिकी क्रममा जीवनको उत्सर्ग गर्ने शहदिका परिवार, वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र वसिस्थापित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई उपचार गर्दा लागेको खर्च व्यहोर्न नसकेको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिलाई उपचारको व्यवस्था गर्न आकस्मिक स्वास्थ्य उपचार कोषको स्थापना गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषको सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-४ ।

रगत, रक्तजन्य पदार्थको प्रयोग तथा मानव अङ्ग प्रत्यारोपण । ३४. रगत सञ्चार सेवा: (१) मन्त्रालयले इजाजतपत्र दिएको संस्थाले मात्र नेपालमा रगत सञ्चार सेवा प्रदान गर्न पाउनेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजमि इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले इजाजतपत्रको अधीनमा रही रगत सञ्चार सेवा प्रदान गर्नका लागि विभिन्न स्थानमा एकाइहरू खडा गरी रगत सञ्चार सेवा तथा सोसँग सम्बन्धित अन्य सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि रगत सञ्चार सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले सेवाग्राहीलाई रगत उपलब्ध गराउँदा त्यस्तो रगतमा कुनै प्रकारको रोगको सङ्क्रमण नभएको सुनिश्चित भएको सुरक्षित रगत मात्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजमि इजाजतपत्र दनि तथा नवीकरण गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३५. मानव अङ्गको प्रत्यारोपण र प्रयोग: मानव अङ्गको प्रत्यारोपण सम्बन्धी व्यवस्था प्रचलति कानून बमोजमि हुनेछ । ३६. शव परीक्षण र व्यवस्थापन गर्ने: (१) प्रचलति कानून बमोजमि शव परीक्षण गर्न अख्तियार प्राप्त चिकित्सकले तोकिए बमोजमि शव परीक्षण गर्नु पर्नेछ । (२) शव परीक्षण पश्चात वेवारसि शवलाई तोकिए बमोजमिको प्रक्रिया पूरा गरी चिकित्सा शास्त्रको अध्ययनमा सदुपयोग गर्न सकिन्छ । ३७. एम्बुलेन्स र शववाहनको व्यवस्था गर्नुपर्ने: (१) मन्त्रालयले तोके बमोजमिका स्वास्थ्य संस्थाले तोकिए बमोजमिको मापदण्डमा रही एम्बुलेन्स र शववाहन सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) एम्बुलेन्स र शववाहनको सेवा सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३८. मानव मृत्युका कारणहरू पहिचान: स्वास्थ्य संस्थामा उपचार लडिरहेको अवस्थामा कसैको मृत्यु भएमा मृत्युको कारण पहिचान गर्न तोकिए बमोजमि परीक्षण गरिन्छ । परिच्छेद-५ । जनस्वास्थ्यको संरक्षण, प्रवर्धन र सुधारका लागि सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय निर्धारक । ३९. उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर : (१) खाद्यान्न, मासु र पानी लगायतका उपभोग्य वस्तु उत्पादन, भण्डारण तथा बिक्री वितरणलाई गुणस्तरीय र स्वच्छ बनाउन नेपाल सरकारले सङ्घीय कानून बमोजमि न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड तोक्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको मापदण्ड पालना गर्नु प्रदेश, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । (३) उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचलति कानून बमोजमि हुनेछ । ४०. ध्वनि र वायु प्रदुषण : (१) ध्वनि, वायु, जल तथा दृश्य प्रदुषणले जनस्वास्थ्यमा पार्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सङ्घीय कानून बमोजमि नेपाल सरकारले यस सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको मापदण्डको

पालना गर्नु प्रदेश तथा स्थानीय तह, आम नागरिक, उद्योगी, व्यवसायी, सङ्घ संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । (३) ध्वनि, वायु, जल तथा दृश्य प्रदुषणले जनस्वास्थ्यमा पार्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि संघीय कानून बमोजमि नेपाल सरकारले ध्वनि, वायु, जल तथा दृश्य प्रदुषण सम्बन्धी मापदण्ड नर्धारण गर्नेछ ।

४१. सरसफाई तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन : (१) वातावरणीय प्रदुषण तथा फोहोरमैलाबाट मानव स्वास्थ्यमा पारेको वा पार्ने प्रतिकूल प्रभावलाई नयिन्त्रण गर्नको लागि नेपाल सरकारले प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजमि आवश्यक मापदण्ड बनाउन सक्नेछ । (२) स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैला संकलन, पुनः प्रयोग, प्रशोधन, वसिर्जन र नयिमनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक मापदण्ड बनाउनेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजमिको मापदण्डको पालना गर्नु प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्तव्य हुनेछ । (४) प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले तोकिएको मापदण्ड बमोजमि जोखिम रहित र जोखिमियुक्त फोहोरहरूलाई छुट्याई व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ । (५) प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले सेवा प्रदायकलाई तोकिएको मापदण्ड बमोजमिको स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ४२. जनस्वास्थ्य मैत्री आवास, सार्वजनिक यातायात र सडक पूर्वाधार तथा सुरक्षा : (१) आवास क्षेत्रहरूको निर्माण गर्दा स्वास्थ्यमैत्री हुने गरी सङ्घीय कानूनले तोकेको मापदण्ड र गुणस्तर कायम गर्नु पर्नेछ । (२) सडक पूर्वाधार निर्माण गर्दा सडक दुर्घटना कम हुने गरी र स्वास्थ्य प्रवर्द्धनलाई ध्यानमा राखी निर्माण गर्नु पर्नेछ । नयाँ बन्ने सडक र पुराना सडकहरूको स्तरोन्नति गर्दा प्रचलित कानून बमोजमि तोकिएको स्थानमा फुटपाथ, अपाङ्गता मैत्री संरचना र साइकल लेनको प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेछ । (३) सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दा जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी वातावरण मैत्री बनाउन नेपाल सरकारले आवश्यक मापदण्ड तोकी कार्यान्वयन गर्न गराउन सक्नेछ । ४३. उद्योग र शहरीकरण : (१) जनस्वास्थ्यमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावको पहिचान गरी रोकथाम गर्न र जोखिम न्यूनीकरण गर्न तोकिएका उद्योग, व्यवसाय तथा आयोजनाको स्वीकृतिले अघि जनस्वास्थ्य प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) अनुसारको जनस्वास्थ्य प्रभाव मूल्याङ्कनको मापदण्ड, संयन्त्र र तहगत कार्यक्षेत्र सङ्घीय कानूनले तोके बमोजमि हुनेछ । (३) कुनै उद्योग, व्यवसाय तथा आयोजनाले उचित प्रकारले फोहोर व्यवस्थापन नगरी वा कुनै प्रकारको विकिरणका कारण जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारेमा सोको कारणले प्रभावित व्यक्तिहरूका लागि स्वास्थ्य उपचार र भौतिक क्षति, पशु पक्षी लगायत अन्य क्षति भएको अवस्थामा सोको उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था सम्बन्धित उद्योगी, व्यवसायी तथा आयोजनाले गर्नु पर्नेछ । (४) सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहले स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पर्याप्त खेल, मनोरञ्जन स्थल, पार्क, पैदल हिँड्ने व्यवस्था, साइकल चलाउन मिल्ने गरी जनस्वास्थ्य मैत्री शहरीकरण प्रवर्द्धनको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (५) नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजमि स्थानीय तहले पाउने अनुदान नर्धारण गर्दा जनस्वास्थ्य मैत्री सूचकाङ्क विकास गरी समावेश गर्नु पर्नेछ । ४४. जोखिमियुक्त क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको स्वास्थ्य सुरक्षा : (१) जोखिमियुक्त क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सम्बन्धित रोजगारदाताले प्रचलित कानून बमोजमिका सुरक्षा उपायहरू अवलम्बन गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिका जोखिमियुक्त क्षेत्रमा कार्य गर्ने कामदार वा कर्मचारीहरूको रोजगारदाताहरूले प्रचलित कानून बमोजमि स्वास्थ्य बीमा गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको जोखिमियुक्त क्षेत्रको कार्यस्थलमा औजार, उपकरण वा अन्य कुनै सामग्रीको प्रयोगका कारण कुनै कर्मचारी वा कामदार घाईते वा मृत्यु भएमा वा कुनै स्वास्थ्यकर्मी सेवा प्रदान गर्ने सलिसलामा गम्भीर संक्रमण वा बरिमी भएमा सम्बन्धित रोजगारदाताले स्वास्थ्य उपचार र उपयुक्त क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमिको जोखिमियुक्त कार्यस्थलमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी वा कामदारहरूलाई सम्बन्धित रोजगारदाताले नेपाल सरकारले तोके बमोजमिको जोखिमि भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ४५. जनस्वास्थ्यलाई प्रभावित पार्ने वज्रिापन तथा प्रचार प्रसार : (१) मदरि, चुरोट, सुरती तथा सूर्तजिन्य पदार्थ लगायतका मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पन विज्रिापन सामग्रीको उत्पादन, वतिरण तथा प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन । (२) मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यलाई असर गर्ने कुनै सामग्री तथा सेवा तर्फ आकर्षित गर्ने गरी गलत वा भ्रामक सूचना राखी वज्रिापनको उत्पादन, वतिरण तथा प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन । ४६. जनस्वास्थ्यलाई प्रभावित पार्ने सामाजिक, साँस्कृतिक अन्धवश्वास : जनस्वास्थ्यलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने सामाजिक र साँस्कृतिक अन्धवश्वास नयिन्त्रण गर्नका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नेछ । ४७. लक्ष्ति समूहहरूका लागि विशेष सामाजिक सुरक्षा तथा कार्यक्रमहरू : (१) महिला, बालबालिका, कशोर कशोरी, दलति, शहीद परिवार र नेपाल सरकारले तोकेका अन्य लक्ष्ति समूहहरूका लागि विशेष सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि लक्ष्ति समूहहरूका लागि दिइने स्वास्थ्य सेवा, सुवधि तथा प्रक्रिया सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-६ । आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा तथा व्यवस्थापन । ४८. आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा तथा व्यवस्थापन : (१) आपतकालीन अवस्थामा तत्कालै स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन तोकिए बमोजमिको द्रुत प्रतिकार्य टोली तथा आपतकालीन चिकित्सकीय समूह रहनेछ । (२) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आपतकालीन स्वास्थ्य योजना विकास गरी लागू गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले योजना विकास गर्दा नेपाल सरकारले सङ्घीय कानून बमोजमि नर्धारण गरेका मापदण्ड तथा नर्देशिकाहरूका अनुरूप हुने गरी गर्नु पर्नेछ । (४)

स्थानीय तहले प्रचलति कानून बमोजमि जनस्वास्थ्य वपिद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ । तर, कुनै वपिद् एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा हुन गएमा सम्बन्धति प्रदेशले र एकभन्दा बढी प्रदेशहरूमा जनस्वास्थ्य वपिद् अवस्था सृजना हुन गएमा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजमि जनस्वास्थ्य वपिद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ ।

(५) जनस्वास्थ्य वपिद् अवस्था घोषणा सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धति सबैका लागि सार्वजनिक माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्नु पर्नेछ । (६) जनस्वास्थ्य वपिद्को समयावधि र क्षेत्र लगायत अन्य पक्षहरूमा उपलब्ध तथ्याङ्क तथा सूचनाका आधारमा थपघट वा हटाउन सकिनेछ । (७) आपतकालीन स्वास्थ्य अवस्था सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ४९. सङ्क्रामक रोगको रोकथाम, सूचना तथा उपचार : (१) सङ्क्रामक रोगहरूको सूची नेपाल सरकारले तोके बमोजमि हुनेछ । (२) कुनै स्थानमा उच्च जोखिम युक्त सङ्क्रामक रोग देखिएमा सोको जानकारी स्वास्थ्य संस्था वा जनस्वास्थ्य अधिकारीलाई दनि सम्बन्धति व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । (३) कुनै व्यक्तिसङ्क्रामक रोगबाट प्रभावति भएको पाइएमा नजिको उपचार व्यवस्थापन सम्बन्धति स्वास्थ्य संस्था वा स्वास्थ्यकर्मीले तत्कालै गर्नु पर्नेछ । (४) सूचीकृत गरिएका सङ्क्रामक रोगहरूको बरिमी पहिचान भएमा सम्बन्धति स्वास्थ्य संस्था वा स्वास्थ्यकर्मीले तोकिएको मापदण्ड बमोजमि सम्बन्धति नकियमा तोकिएको समयावधिभित्र सूचना सम्प्रेषण गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि प्राप्त सूचनाको आधारमा प्रदेश र मन्त्रालयसँग आवश्यक सहयोग लई समयमै थप अध्ययन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी तोकिए बमोजमि स्थानीय तहको हुनेछ । (६) स्वास्थ्य संस्थाले सङ्क्रामक रोग लागेका बरिमीको उपचारका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (७) सङ्क्रामक रोगको रोकथाम सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-७. राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समिति । ५०. राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समिति : (१) मानव स्वास्थ्यको वषियमा प्रभाव पार्ने स्वास्थ्यका बृहत सामाजिक निर्धारकहरूलाई सम्बोधन गर्न वषियगत क्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रमहरूमा जनस्वास्थ्यका मुद्दाहरूलाई समावेश गर्ने सम्बन्धमा नीतित्त सुझाव दनिको लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समितिको गठन गरिनेछ । (२) समितिको गठन देहाय बमोजमि हुनेछ :- (क) मन्त्री, स्वास्थ्य सम्बन्धी वषिय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय - अध्यक्ष । (ख) राज्यमन्त्रीसहायक मन्त्री, स्वास्थ्य सम्बन्धी वषिय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय - सह अध्यक्ष । (ग) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (स्वास्थ्य सम्बन्धी वषिय हेर्ने) - सदस्य । (घ) स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित एक जना - सदस्य । (ङ) सचिव, उद्योग सम्बन्धी वषिय हेर्ने नेपाल सरकारको - सदस्य । सरकारको मन्त्रालय - सदस्य । (च) सचिव, अर्थ सम्बन्धी वषिय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय - सदस्य । (छ) सचिव, कृषि सम्बन्धी वषिय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय - सदस्य । (ज) सचिव, खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी वषिय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय - सदस्य । (झ) सचिव, गृह सम्बन्धी वषिय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय - सदस्य । (ञ) सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सम्बन्धी वषिय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय - सदस्य ।

(ट) सचिव, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी वषिय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय - सदस्य । (ठ) सचिव, वन तथा वातावरण सम्बन्धी वषिय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय - सदस्य । (ड) सचिव, शिक्षा सम्बन्धी वषिय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय - सदस्य । (ढ) सचिव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी वषिय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय - सदस्य । (ण) सचिव, स्वास्थ्य सम्बन्धी वषिय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय - सदस्य । (त) प्रमुख विशेषज्ञ, स्वास्थ्य सम्बन्धी वषिय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय - सदस्य । (थ) अध्यक्ष, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धति परिषद्हरूमध्येबाट एक जना मनोनीत - सदस्य । (द) स्वास्थ्य विज्ञहरूमध्येबाट अध्यक्षले मनोनीत गरेको एक जना - सदस्य । (ध) नजी स्वास्थ्य संस्थाका सञ्चालकमध्ये अध्यक्षले मनोनीत एक जना महिलासहित दुई जना - सदस्य । (न) उपभोक्ता हित संरक्षणसँग सम्बन्धति सङ्ग संस्थाका पदाधिकारीहरूमध्ये अध्यक्षले मनोनीत गरेको एक जना - सदस्य । (प) प्रमुख, नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या सम्बन्धी वषिय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय - सदस्य सचिव । (३) उपदफा (२) को खण्ड (घ), (थ), (द), (ध) र (न) बमोजमि मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (४) समितिले आवश्यकता अनुसार अन्य विज्ञहरूलाई बैठकमा आमन्त्रित गर्न सक्नेछ । (५) समितिले बैठक वर्षमा कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ । (६) समितिको दैनिक कार्य सम्पादनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या सम्बन्धी वषिय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा सचिवालयको कार्य गर्नेछ । (७) समितिको कार्यवधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । ५१. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- (क) नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा, सम्वर्द्धन र सुधार सम्बन्धी स्वास्थ्यमा बहुक्षेत्रीय आयामको अवधारणा अनुरूप मार्गनिर्देशन, अनुगमन, नीति निर्माण गर्ने, । (ख) स्वास्थ्यका बृहत सामाजिक निर्धारकहरूलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारका अन्य सबै नीतिहरूमा स्वास्थ्य नीति अवलम्बन गर्ने गराउने, । (ग) स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा समानुपातिक वितरणको आधारमा बहुक्षेत्रीय लक्ष्य एवं प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, । (घ) स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी समन्वयको व्यवस्था गर्ने, । (ङ) जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धति अन्तर्राष्ट्रिय नीति, रणनीति तथा प्रतिबद्धतालाई नेपालको राष्ट्रिय हतिमा लागू गर्न सहकार्य, समन्वय तथा अनुगमन गर्ने, । (च) विभिन्न प्रयोजनका

लागि प्रयोग हुने वषिदको नयिन्तरण गर्न र सडक तथा यातायातजन्य दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न आवश्यक नीति निर्माण गर्न र व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दनि, । (छ) स्थानीय स्तरका विद्यालयमा प्राथमिक उपचार र स्वास्थ्य शिक्षाको प्रवर्द्धन गर्न जनस्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्न आवश्यक सुझाव दनि, । (ज) नेपाल सरकारले तोकेको अन्य कार्य गर्ने ।

(२) समितिले आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-८ । कसूर र सजाय । ५२. कसूर : कसैले देहाय बमोजमिका कार्य गरेमा यो ऐन अन्तर्गतको कसूर गरिने मानिन्छ:- । (क) दफा २२ बमोजमि इजाजतपत्र नलिई स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गरेमा तथा दफा ३४ बमोजमि इजाजतपत्र नलिई रक्त सञ्चार सेवा सञ्चालन गरेमा, । (ख) स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्न इन्कार गरेमा, । (ग) मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई बाँधेर राख्ने वा खोरमा थुन्ने जस्ता कार्य गरी उपचार गरेमा, । (घ) स्वास्थ्य संस्थाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध हुने आकस्मिक उपचार प्रदान गर्न इन्कार गरेमा, । (ङ) दफा ११ बमोजमि सुसूचि सहमतिले उपचार सेवा प्रदान गरेमा, । (च) दफा १२ बमोजमि सेवाग्राहीलाई समान व्यवहार नगरेमा, । (छ) दफा १४ बमोजमि गोपनीयता कायम नगरेमा, । (ज) स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्यसंस्थालाई यो ऐन अन्तर्गतको कर्तव्य नरिवाह गर्न बाधा व्यवधान उत्पन्न गरेमा, । (झ) स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थालाई यो ऐन बमोजमि सूचना वा जानकारी गराउनु पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो सूचना वा जानकारी उपलब्ध नगराएमा, । (ञ) स्वास्थ्यकर्मी वा सेवाप्रदायकलाई जानीजानी गलत सूचना उपलब्ध गराएमा, । (ट) स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थालाई झुक्याउन अर्को व्यक्तिभएको बहाना गरेमा, । (ठ) यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम, मापदण्ड, निर्देशिका तथा कार्यवधि बमोजमि जारी भएको सूचना पालना नगरेमा, । (ड) दफा ३९ र ४० बमोजमि खाद्य पदार्थ, पानी तथा वायुको गुणस्तरका कारण जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पारेमा, । (ढ) दफा ४५ विपरीत कसैले विज्ञापन गरेको पाइएमा, । (ण) प्रचलित कानून बमोजमि स्वीकृत नलिई मानव जैविक नमूना सङ्कलन गर्न तथा मुलुक बाहिर लैजाने कार्य गरेमा, । (त) यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम, मापदण्ड, निर्देशिका तथा कार्यवधि विपरीतको अन्य कुनै कार्य गरेमा । ५३. सजाय : दफा ५२ बमोजमिको कसूरमा देहाय बमोजमि सजाय हुनेछ:- । (क) खण्ड (क) र (ण) बमोजमिको कसूर गरेमा दश लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय, । (ख) खण्ड (ख), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ठ), (ड) र (त) बमोजमिको कसूर गरेमा पच्चीस हजारदेखि पचास हजारसम्म जरिवाना, । (ग) खण्ड (ग) बमोजमिको कसूर गरेमा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय, । (घ) खण्ड (ढ) बमोजमिको कसूर गरेमा विज्ञापन प्रसारण गर्नेलाई दश हजार रुपैयाँ जरिवाना । ५४. अनुसन्धान गर्ने अधिकारी: यस ऐन अन्तर्गत कसूर ठहरिने मुद्दाको अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने अधिकार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारीलाई हुनेछ । ५५. नेपाल सरकार बादी हुने : यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार बादी हुनेछ । ५६. मुद्दा हेर्ने र पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी : (१) यस ऐन बमोजमि कसूर ठहरिने मुद्दाको शुुरु कारबाही र कनिरा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि जिल्ला अदालतले गरेको नरिणयमा चर्तित नबुझ्ने पक्षले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

५७. कर्षतपूरति: (१) यस ऐन बमोजमि कसूर ठहर भएको अवस्थामा मर्का पर्न गएको पक्षलाई पुग्न गएको वास्तविक हानि, नोक्सानी बापत मुद्दा हेर्ने अधिकारीले कसूरदारबाट उपयुक्त कर्षतपूरति भिराउने आदेश दनिछ । (२) कर्षतपूरति भिराउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-९ । विविधि । ५८. मन्त्रालयको स्वीकृतिलेनु पर्ने : (१) मानव जैविक नमूना सङ्कलन गर्न तथा त्यस्तो नमूना मुलुक बाहिर लैजानुपूर्व मन्त्रालयको स्वीकृतिलेनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ड तथा कार्यवधि बिनाई लागू गर्न सक्नेछ । ५९. अभिलेख राख्ने : स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिएका हरेक सेवाग्राहीको तोकिए बमोजमिको अभिलेख सुरक्षित रूपमा राख्ने व्यवस्था मल्लिउनु सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाको प्रमुखको कर्तव्य हुनेछ । ६०. प्रतविदन पेश गर्ने : (१) प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले आफूले प्रदान गरेको सेवाको विवरण समेत समावेश गरी प्रत्येक वर्ष इजाजतपत्र प्रदान गर्ने नकिय समक्ष तोकै बमोजमि प्रतविदन पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश र स्थानीय तहले इजाजतपत्र दिई सञ्चालन भएका स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गरेको सेवाको सम्बन्धमा उपदफा (१) बमोजमि सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाबाट प्राप्त प्रतविदनका आधारमा सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले एकमुष्ट प्रतविदन तयार गरी मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको प्रतविदन पठाउँदा प्रचलित कानून बमोजमि प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका जनस्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम समेतको विवरण संलग्न गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि प्राप्त प्रतविदनका आधारमा मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार निर्देशन दनि सक्नेछ । ६१. प्रचलित कानून बमोजमि हुने : यस ऐनमा लेखिए जतकिरामा यसै ऐन बमोजमि र अन्य कुराको हकमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजमि हुनेछ । ६२. अधिकार प्रत्यायोजन : अधिकारप्राप्त अधिकारीले यो ऐन बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकारहरु कुनै अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ६३. नयिम बनाउने अधिकार : यो ऐन कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नयिमहरू बनाउन सक्नेछ । ६४. मापदण्ड वा निर्देशिका वा कार्यवधि बिनाउने अधिकार : मन्त्रालयले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमको अधीनमा रही आवश्यक मापदण्ड वा निर्देशिका वा कार्यवधि बिनाउन सक्नेछ ।